



CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

DISCIPLINA:

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH)



APH



RCP



DEA



TRAUMA



EMERGÊNCIAS



RESGATE



VIDAS
EM PRIMEIRO
LUGAR



CONHECIMENTO
TÉCNICA
MISSÃO

PREPARAÇÃO, TÉCNICA E CORAGEM
PARA SALVAR VIDAS!

VERSÃO 1.0

2024



APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

O Atendimento Pré-Hospitalar (APH) é o conjunto de procedimentos realizados fora do ambiente hospitalar, com o objetivo de preservar a vida, prevenir o agravamento das lesões e promover o transporte seguro da vítima até um serviço de saúde adequado.

O Bombeiro Profissional Civil é frequentemente o primeiro a chegar ao local da ocorrência e sua atuação técnica, rápida e segura é determinante para o desfecho positivo do atendimento.



OBJETIVOS DA DISCIPLINA

- Capacitar o aluno a reconhecer e atuar em situações de emergência e urgência.
- Fornecer conhecimentos técnicos e científicos para a prestação de um APH eficaz e seguro.
- Desenvolver habilidades para avaliação, tomada de decisão e execução das principais condutas pré-hospitais.
- Promover a integração com os sistemas de emergência e a equipe multiprofissional.



IMPORTÂNCIA DO APH

- ✓ O APH realizado de forma correta pode ser a diferença entre a vida e a morte.
- ✓ Reduz complicações e sequelas.
- ✓ Aumenta as chances de recuperação da vítima.
- ✓ Contribui para o sistema de saúde e para a segurança da sociedade.
- ✓ O tempo resposta e a qualidade do atendimento são fatores críticos para o sucesso.



COMPETÊNCIAS DO BOMBEIRO CIVIL NO APH

- ✓ Avaliar rapidamente a cena e a vítima.
- ✓ Identificar riscos e adotar medidas de segurança.
- ✓ Realizar avaliação primária e secundária.
- ✓ Executar técnicas de suporte básico de vida.
- ✓ Controlar hemorragias e imobilizar fraturas.
- ✓ Prestar cuidados adequados conforme a ocorrência.
- ✓ Comunicar-se de forma clara e objetiva.
- ✓ Atuar com ética, empatia e responsabilidade.



POSTURA PROFISSIONAL

- ✓ Manter a calma e o autocontrole.
- ✓ Agir com empatia e respeito à vítima.
- ✓ Trabalhar em equipe de forma coordenada.
- ✓ Respeitar os protocolos e normas técnicas.
- ✓ Registrar as informações de forma correta e completa.



COMPETÊNCIA GERAL DA DISCIPLINA

Ao final desta disciplina, o aluno será capaz de prestar atendimento pré-hospitalar seguro, ético e tecnicamente correto, desde a avaliação da cena até o transporte da vítima, integrando-se aos sistemas de emergência e contribuindo para a preservação da vida.



LEMBRE-SE!

Você representa a FARN e a sociedade em cada atendimento. Sua conduta pode salvar vidas!



ÉTICA



SEGURANÇA



TRABALHO EM EQUIPE



CONHECIMENTO



ATENDIMENTO HUMANIZADO



CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

DISCIPLINA:
**ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR (APH)**



INTRODUÇÃO AO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

O Atendimento Pré-Hospitalar (APH) compreende o conjunto de ações realizadas fora do ambiente hospitalar, com o objetivo de preservar a vida, prevenir o agravamento das lesões e promover o transporte seguro da vítima até um serviço de saúde adequado.

É uma atividade que exige preparo técnico, raciocínio rápido, cuidado, empatia e trabalho em equipe, sendo fundamental na cadeia de sobrevivência.



HISTÓRICO

- Iniciado no século XX com os primeiros socorros em campos de batalha.
- Evoluiu com guerras, desastres e o aumento de acidentes.
- No Brasil, ganhou força com a criação do SAMU (2003) e com a profissionalização do atendimento.
- Hoje é uma ciência baseada em protocolos e evidências.



EVOLUÇÃO DO APH

- De ações empíricas para protocolos padronizados.
- De transporte simples para suporte avançado de vida.
- De atuação isolada para sistemas integrados de emergência.
- De atendimento reativo para prevenção e educação em saúde.



MISSÃO

Salvar vidas, reduzir o sofrimento e as sequelas, até a chegada da vítima a um serviço de saúde definitivo, por meio de ações técnicas, éticas e seguras.



IMPORTÂNCIA DO APH

Intervenções rápidas e corretas fazem a diferença entre a vida e a morte. O APH é o elo entre o acidente e o tratamento definitivo, sendo decisivo na recuperação da vítima.



COMPETÊNCIAS DO BOMBEIRO CIVIL NO APH

- | | |
|--|---|
| ✓ Atuar com segurança, técnica e responsabilidade. | ✓ Trabalhar em equipe de forma integrada. |
| ✓ Avaliar rapidamente a cena e a vítima. | ✓ Registrar as informações de forma correta. |
| ✓ Executar condutas de suporte básico de vida. | ✓ Agir com ética, respeito e empatia. |
| ✓ Controlar hemorragias e imobilizar fraturas. | ✓ Respeitar protocolos, normas e legislações. |
| ✓ Comunicar-se de forma clara e objetiva. | ✓ Buscar constante atualização e treinamento. |



BOMBEIRO CIVIL:
TÉCNICA, CORAGEM
E COMPROMISSO
COM A VIDA!



ATENÇÃO!

Cada segundo conta.
Sua atitude pode
ser decisiva!



LEMBRE-SE

Conhecimento + Habilidade + Atitude =
Atendimento de Qualidade





CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

DISCIPLINA: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH)



2.1 INTRODUÇÃO E ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DOS APH

O Atendimento Pré-Hospitalar (APH) é uma atividade que envolve, além do conhecimento técnico-científico, uma grande responsabilidade ética e legal. O Bombeiro Profissional Civil deve atuar dentro dos princípios éticos e das leis que regem sua profissão, garantindo um atendimento seguro, humanizado e responsável.



ÉTICA NO APH

A ética é o conjunto de princípios que norteiam a conduta do profissional na tomada de decisão e na execução de suas ações.

- Respeito à vida e à dignidade humana.
- Imparcialidade no atendimento, sem discriminação.
- Preservação da intimidade e da integridade da vítima.
- Sigilo das informações obtidas durante o atendimento.
- Atuação com competência, prudência e responsabilidade.



ASPECTOS LEGAIS

O Bombeiro Profissional Civil deve conhecer e cumprir as leis e normas que regulam sua atuação no APH.



RESPONSABILIDADE CIVIL

Ocorre quando há dano causado à vítima por negligência, imprudência ou imperícia.

Pode gerar obrigação de indenizar os prejuízos causados.



RESPONSABILIDADE PENAL

Ocorre quando há infração à lei penal.

Ex.: omissão de socorro, lesão corporal, exposição da vida ou saúde da vítima a perigo.

Pode resultar em prisão e penalidades.



RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA

Relacionada ao descumprimento de normas e regulamentos da corporação ou do serviço.

Pode gerar advertência, suspensão ou demissão.



OMISSÃO DE SOCORRO

Deixar de prestar socorro a alguém em perigo, quando possível fazê-lo sem risco pessoal.

É crime previsto no art. 135 do Código Penal.



SIGILO PROFISSIONAL

Todas as informações obtidas durante o atendimento são confidenciais e não devem ser divulgadas, exceto quando necessárias para a continuidade do cuidado ou por obrigação legal.



ATENÇÃO!

A conduta ética e legal é tão importante quanto o conhecimento técnico. Uma decisão incorreta pode salvar ou colocar uma vida em risco e também gerar graves consequências legais para o profissional.



PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

- ✓ Legalidade: agir conforme a lei e os protocolos.
- ✓ Impessoalidade: tratar todas as vítimas com igualdade.
- ✓ Moralidade: agir com honestidade e integridade.
- ✓ Publicidade: registrar corretamente todos os atendimentos.
- ✓ Eficiência: buscar sempre o melhor resultado possível.



LEMBRE-SE

O respeito à vida, a ética e o conhecimento da lei são os pilares da atuação profissional do Bombeiro Civil no APH.



ÉTICA



SEGURANÇA



RESPONSABILIDADE



LEGALIDADE



CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

DISCIPLINA:
**ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR (APH)**



2.2 LEGISLAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH)

O Atendimento Pré-Hospitalar (APH) é regulamentado por um conjunto de leis, decretos, portarias e normas técnicas que estabelecem as diretrizes para a atuação segura, eficaz e ética dos profissionais de emergência.

O Bombeiro Profissional Civil deve conhecer e aplicar essas normas em todas as etapas do atendimento.



FUNDAMENTOS LEGAIS DO APH

- A legislação define responsabilidades, competências e limites de atuação.
- Garante segurança jurídica ao profissional e à vítima.
- Estabelece padrões de qualidade e protocolos assistenciais.
- Promove a integração entre os serviços de emergência.



PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES E NORMAS



Lei nº 11.901/2009

Regulamenta a profissão de Bombeiro Civil em todo o território nacional.



Portaria GM/MS nº 2.048/2002

Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência.



Portaria GM/MS nº 1.010/2012

Redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação.



Portaria GM/MS nº 2048/2009

Dispõe sobre a organização dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência.



ABNT NBR 14561:2020

Atendimento pré-hospitalar – Requisitos para programas de treinamento de brigadistas profissionais.



RESOLUÇÕES E DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

- ✓ Define diretrizes nacionais para o APH.
- ✓ Padroniza protocolos e fluxos de atendimento.
- ✓ Estabelece competências das equipes e dos serviços.
- ✓ Orienta sobre capacitação, recursos materiais e integração dos sistemas.
- ✓ Garantem a qualidade e a continuidade do cuidado à vítima.



RESPONSABILIDADES DO BOMBEIRO CIVIL

- ✓ Conhecer e cumprir todas as legislações e normas vigentes.
- ✓ Atuar dentro dos protocolos e limites de sua formação.
- ✓ Manter-se atualizado sobre alterações legais e técnicas.
- ✓ Registrar corretamente todas as informações do atendimento.
- ✓ Zelar pela segurança da vítima, da equipe e da cena.



ATENÇÃO!

O desconhecimento da legislação NÃO isenta o profissional de responsabilidade. Agir fora das normas pode configurar imperícia, imprudência ou negligência, sujeitando o profissional a sanções administrativas, civis e penais.



BOAS PRÁTICAS

- ✓ Estude e mantenha-se atualizado sobre as leis e normas.
- ✓ Participe de treinamentos e reciclagens.
- ✓ Siga rigorosamente os protocolos estabelecidos.
- ✓ Registre todas as informações de forma clara e objetiva.
- ✓ Em caso de dúvida, acione a Central de Regulação Médica.



REFERÊNCIAS IMPORTANTES

- ✓ Lei nº 11.901/2009 – Profissão de Bombeiro Civil
- ✓ Portaria GM/MS nº 2.048/2002 – Regulamento dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência
- ✓ Portaria GM/MS nº 1.010/2012 – SAMU 192
- ✓ ABNT NBR 14561:2020 – Requisitos para treinamento de brigadistas profissionais
- ✓ Demais portarias e resoluções do Ministério da Saúde pertinentes ao APH



CONHECIMENTO
TÉCNICA
MISSÃO

PREPARAÇÃO, TÉCNICA E CORAGEM
PARA SALVAR VIDAS!



PÁGINA **05**



CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

DISCIPLINA: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH)



2.3 SISTEMAS DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES

O atendimento pré-hospitalar é realizado de forma integrada entre órgãos e instituições, garantindo resposta rápida, eficiente e segura à população.

Cada sistema possui funções específicas, porém todos trabalham de forma coordenada para salvar vidas.



PRINCIPAIS SISTEMAS E ÓRGÃOS ENVOLVIDOS



SAMU 192

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Atendimento pré-hospitalar móvel, 24h por dia, regulado por centrais de regulação médica.



CORPO DE BOMBEIROS

Atendimento a emergências, resgates, traumas, incêndios, acidentes e apoio ao SAMU.



DEFESA CIVIL

Atuação em desastres, calamidades públicas, riscos naturais e tecnológicos.



POLÍCIA MILITAR

Segurança da cena, isolamento da área, apoio operacional e controle do tráfego.



HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE

Recepção, estabilização e continuidade do tratamento à vítima.



CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INTEGRADO

- ✓ Atendimento rápido e coordenado.
- ✓ Comunicação eficiente entre os órgãos.
- ✓ Uso de protocolos padronizados.
- ✓ Integração entre regulação médica e operacional.
- ✓ Foco na segurança da vítima, da equipe e da cena.
- ✓ Registro e compartilhamento de informações.



FLUXO DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR



IMPORTANTE!

A eficiência do sistema depende de cada profissional conhecer seu papel, respeitar os protocolos e manter a comunicação constante.



NÚMEROS DE EMERGÊNCIA

	SAMU	192
	CORPO DE BOMBEIROS	193
	POLÍCIA MILITAR	190
	DEFESA CIVIL	199

AO ACIONAR, INFORME:

- ✓ O que aconteceu.
- ✓ Local exato (endereço e referências).
- ✓ Número de vítimas e estado aparente.
- ✓ Seu nome e telefone para contato.



BOAS PRÁTICAS

- ✓ Mantenha a calma ao acionar.
- ✓ Forneça informações claras e objetivas.
- ✓ Siga as orientações da central.
- ✓ Confie no trabalho das equipes.
- ✓ Não interrompa a ligação até ser orientado.



CONHECIMENTO
TÉCNICA
MISSÃO

PREPARAÇÃO, TÉCNICA E CORAGEM
PARA SALVAR VIDAS!



PÁGINA **06**



CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

DISCIPLINA:
**ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR (APH)**



2.4 AVALIAÇÃO DA CENA

A avaliação da cena é o primeiro passo ao chegar no local da ocorrência. Ela permite identificar riscos, planejar a abordagem e garantir a segurança da equipe, da vítima e de terceiros.

Nunca se torne mais uma vítima!



OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO DA CENA

- Garantir a segurança da equipe e da vítima.
- Identificar o mecanismo do trauma ou a natureza da doença.
- Determinar o número de vítimas e a gravidade aparente.
- Identificar os recursos necessários.
- Planejar a abordagem e o atendimento inicial.



PASSOS PARA AVALIAÇÃO DA CENA

1 OBSERVAÇÃO À DISTÂNCIA



- Pare a uma distância segura.
- Observe o cenário geral antes de se aproximar.
- Identifique perigos visíveis.

2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS



- Trânsito, fogo, vazamentos, fios elétricos, explosões, desabamentos, armas, agressões, animais, entre outros.
- Avalie se o local é seguro para você e sua equipe.

3 AVALIAÇÃO DA CENA



- Natureza do evento (trauma, clínico, ambiental, etc.).
- Número de vítimas.
- Condições da cena (acesso, iluminação, clima, espaço).

4 DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES



- Estabeleça prioridades de atendimento.
- Solicite recursos adicionais, se necessário.
- Defina a melhor estratégia de ação.

5 APROXIMAÇÃO SEGURA



- Informe sua equipe sobre os riscos.
- Use EPIs adequados.
- Aproxime-se da vítima com cautela.
- Faça contato verbal e se identifique.



PERGUNTAS-CHAVE NA AVALIAÇÃO DA CENA

- ✓ É seguro para mim e para minha equipe?
- ✓ Qual é o mecanismo do trauma ou o problema clínico?
- ✓ Quantas vítimas há?
- ✓ Quais são os riscos presentes ou potenciais?
- ✓ Quais recursos já estão disponíveis?
- ✓ Que recursos adicionais preciso solicitar?
- ✓ Qual será a melhor abordagem para o atendimento?



ATENÇÃO!

Riscos não identificados podem mudar rapidamente.
Reavalie a cena constantemente durante todo o atendimento.



EXEMPLOS DE PERIGOS COMUNS



Trânsito e veículos em movimento



Fogo e explosões



Vazamentos de produtos químicos



Fios elétricos e eletricidade



Estruturas instáveis



Agressões e violência



Condições ambientais (chuva, calor, frio)



BOAS PRÁTICAS



Trabalhe em equipe e comunique-se sempre.



Mantenha a calma e seja observador.



Registre as informações importantes da cena.



Reavalie a cena constantemente.



Priorize sempre a segurança da vítima, da equipe e de terceiros.



CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

DISCIPLINA:
ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR (APH)



3.1 AVALIAÇÃO PRIMÁRIA: XABCD E

A avaliação primária tem como objetivo identificar e tratar imediatamente as ameaças à vida, seguindo uma sequência lógica e rápida. O protocolo mais utilizado é o XABCD E.



PRIORIDADE:

Tratar primeiro o que mata primeiro!



O QUE É O XABCD E?

É um protocolo padronizado que orienta a avaliação rápida e sistemática do paciente crítico.

- ✓ Permite identificar e tratar problemas que ameaçam a vida.
- ✓ Deve ser realizado de forma sequencial e contínua.
- ✓ Se algo for encontrado, trate antes de seguir adiante.
- ✓ Reavalie constantemente durante todo o atendimento.



COMPONENTES DO XABCD E

X

CONTROLE DE HEMORRAGIAS EXSANGUINANTES



- Verifique e controle qualquer sangramento grave.
- Use pressão direta, curativos compressivos ou torniquete, se necessário.

A

VIA AÉREA E CONTROLE DA COLUMNA CERVICAL



- Verifique se a via aérea está pérvia.
- Remova obstruções, se houver.
- Mantenha a estabilização manual da coluna cervical.

B

VENTILAÇÃO (BREATHING)



- Avalie a respiração.
- Observe frequência, profundidade e esforço respiratório.
- Administre oxigênio, se necessário.

C

CIRCULAÇÃO (CIRCULATION)



- Verifique pulso, perfusão e tempo de enchimento capilar.
- Controle hemorragias.
- Avalie sinais de choque.

D

AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA (DISABILITY)



- Avalie nível de consciência (AVPU ou Escala de Glasgow).
- Verifique pupilas e mobilidade.

E

EXPOSIÇÃO/ EXAME COMPLETO E AMBIENTE



- Exponha o paciente para exame completo.
- Procure outras lesões.
- Previna hipotermia: mantenha aquecido.



PONTOS IMPORTANTES

- ✓ Siga a ordem do XABCD E, mas trate o mais grave primeiro.
- ✓ A avaliação é dinâmica: reavalie constantemente.
- ✓ Comunicação clara com a equipe e atualização do quadro são essenciais.
- ✓ A segurança da cena e de todos deve ser prioridade.
- ✓ Use EPIs e protocolos adequados em todas as etapas.



SINAIS DE ALERTA DURANTE A AVALIAÇÃO PRIMÁRIA

- Hemorragia ativa e abundante.
- Via aérea obstruída ou risco de obstrução.
- Respiração inadequada ou ausente.
- Sinais de choque (palidez, sudorese, pulso fraco, hipotensão).
- Rebaixamento do nível de consciência.



ATENÇÃO!

Um pequeno sangramento não controlado pode evoluir para choque e morte. Uma via aérea não desobstruída pode causar parada cardiorrespiratória. A rapidez e a sequência correta salvam vidas!



DICAS DO PROFISSIONAL

- ✓ Mantenha a calma e seja objetivo.
- ✓ Fale com a vítima: ela pode fornecer informações importantes.
- ✓ Use comandos curtos e claros com a equipe.
- ✓ Antecipe materiais e equipamentos necessários.
- ✓ Registre todas as informações relevantes.



TÉCNICA, CORAGEM
E COMPROMISSO
COM A VIDA!

PREPARAÇÃO HOJE,
PARA SALVAR VIDAS AMANHÃ!



PÁGINA 08



CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

DISCIPLINA: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH)



3.2 ANATOMIA E FISIOLOGIA

O conhecimento básico da anatomia e da fisiologia humana é fundamental para compreender as alterações causadas por traumas ou doenças e prestar um atendimento seguro, eficiente e direcionado.



POR QUE É IMPORTANTE?

- ✓ Permite identificar rapidamente alterações no organismo.
- ✓ Auxilia na avaliação da gravidade da vítima.
- ✓ Orienta a execução correta das manobras e procedimentos.
- ✓ Reduz riscos de erros e complicações.
- ✓ Aumenta a segurança da equipe e da vítima.

PRINCIPAIS ESTRUTURAS ANATÔMICAS

CABEÇA

Abriga o cérebro, os sentidos e estruturas vitais.

TÓRAX

Protege órgãos vitais como coração e pulmões.

ABDOMEN

Contém órgãos como fígado, estômago, baço, pâncreas e intestinos.

MEMBROS SUPERIORES

Permitem a realização de movimentos e funções diversas.

MEMBROS INFERIORES

Sustentam o corpo, permitem a locomoção e o equilíbrio.

PELVIS

Protege órgãos pélvicos e dá sustentação ao corpo.



PRINCIPAIS SISTEMAS DO CORPO HUMANO



SISTEMA CIRCULATÓRIO

Responsável pelo transporte de sangue, oxigênio, nutrientes e hormônios para todas as partes do corpo.

Órgãos principais: coração, vasos sanguíneos e sangue.



SISTEMA RESPIRATÓRIO

Responsável pelas trocas gasosas, fornecendo oxigênio ao corpo e eliminando o dióxido de carbono.

Órgãos principais: nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões.



SISTEMA NERVOSO

Responsável pelo controle e coordenação das funções do corpo e pelas respostas aos estímulos.

Órgãos principais: cérebro, medula espinhal e nervos.



SISTEMA MUSCULAR

Responsável pelos movimentos, manutenção da postura e produção de calor.

Órgãos principais: músculos esqueléticos, lisos e cardíaco.



SISTEMA ESQUELÉTICO

Responsável pelo suporte, proteção dos órgãos e produção de células do sangue.

Órgãos principais: ossos, cartilagens e articulações.



SISTEMA DIGESTÓRIO

Responsável pela digestão dos alimentos e absorção de nutrientes.

Órgãos principais: boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado e pâncreas.

SINAIS VITAIS NORMAIS EM ADULTOS



FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC)

Batimentos do coração por minuto.

60 a 100 bpm



FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR)

Respirações por minuto.

12 a 20 irpm



PRESSÃO ARTERIAL (PA)

Força do sangue contra as paredes das artérias.

90/60 a 120/80 mmHg



TEMPERATURA CORPORAL (T)

Equilíbrio térmico do corpo.

36 °C a 37,5 °C



SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SpO₂)

Percentual de oxigênio no sangue.

95% a 100%

* Valores podem variar conforme idade, condição física e clínica da vítima.



FUNÇÕES VITAIS

- ✓ Manter a oxigenação.
- ✓ Manter a circulação.
- ✓ Manter a consciência.
- ✓ Manter a temperatura corporal.
- ✓ Manter o equilíbrio hídrico e eletrolítico.
- ✓ Eliminar toxinas e resíduos.
- ✓ Manter a integridade estrutural do corpo.



ATENÇÃO!

Alterações nas funções vitais podem indicar risco de vida! Avalie, identifique e trate rapidamente.



BOAS PRÁTICAS

- ✓ Estude e revise continuamente a anatomia e fisiologia.
- ✓ Relacione o conhecimento teórico com a prática.
- ✓ Observe sinais e sintomas com atenção.
- ✓ Use o conhecimento para tomar decisões seguras.
- ✓ Trabalhe sempre com segurança e responsabilidade.



LEMBRE-SE

Conhecer o corpo humano é essencial para salvar vidas com técnica, agilidade e precisão no atendimento pré-hospitalar.



IMPORTANTE!

Cada vítima é única. Avalie sempre o contexto, a cena e o mecanismo de trauma para um atendimento individualizado e eficaz.



CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

DISCIPLINA: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH)



3.3 SINAIS VITAIS E AVALIAÇÃO INICIAL

Os sinais vitais são indicadores das funções básicas do organismo. Sua avaliação fornece informações essenciais sobre o estado geral da vítima e orienta as prioridades do atendimento.

PRINCIPAIS SINAIS VITAIS

	FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC): Número de batimentos cardíacos por minuto.	60 a 100 bpm
	FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR): Número de respirações por minuto.	12 a 20 irpm
	PRESSÃO ARTERIAL (PA): Força do sangue contra as paredes das artérias.	90/60 a 120/80 mmHg
	TEMPERATURA CORPORAL (T): Equilíbrio térmico do corpo.	36 °C a 37,5 °C
	SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SpO₂): Percentual de oxigênio no sangue.	95% a 100%



MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

- ✓ Avalie em ambiente seguro para você, a equipe e a vítima.
- ✓ Utilize os sentidos: observe, ouça, sinta e pergunte.
- ✓ Compare os sinais encontrados com os valores de referência.
- ✓ Identifique alterações e comunique à equipe.
- ✓ Reavalie constantemente e registre as informações.

COMO AVALIAR OS SINAIS VITAIS

CORAÇÃO



Frequência Cardíaca
Palpe o pulso (radial ou carotídeo) por 30 a 60 segundos e multiplique por 2 para obter o valor por minuto.

RESPIRAÇÃO



Frequência Respiratória
Observe a expansão do tórax ou abdome por 30 a 60 segundos e multiplique por 2.

PRESSÃO ARTERIAL



Pressão Arterial
Utilize esfigmomanômetro e estetoscópio. Meça preferencialmente no braço (artéria braquial).

TEMPERATURA



Temperatura Corporal
Meça com termômetro digital nas axilas, boca ou tímpano, conforme o disponível.

SATURAÇÃO



Saturação de Oxigênio
Utilize oxímetro de pulso, coloque no dedo da mão e aguarde a leitura estabilizar.

ALTERAÇÕES COMUNS E POSSÍVEIS CAUSAS

FC ALTERADA

- **Taquicardia:** dor, febre, choque, hipovolemia.
- **Bradicardia:** hipotermia, lesão neurológica, medicamentos.

FR ALTERADA

- **Taquipneia:** dor, ansiedade, hipóxia, febre.
- **Bradipneia ou apneia:** depressão do sistema nervoso central, obstrução de vias aéreas.

PA ALTERADA

- **Hipotensão:** choque, hemorragia, desidratação.
- **Hipertensão:** dor, estresse, doenças crônicas.

SpO₂ BAIXA

- Indica oxigenação insuficiente do sangue.
- Pode ser causada por hipóxia, doenças respiratórias, choque.

AVALIAÇÃO INICIAL: PASSO A PASSO



ATENÇÃO!

- Alterações nos sinais vitais podem evoluir rapidamente.
- Reavalie a vítima a cada 5 minutos ou sempre que houver mudança no quadro.
- Documente todas as avaliações para garantir continuidade do cuidado.



BOAS PRÁTICAS

- ✓ Seja calmo e detalhista.
- ✓ Use equipamentos calibrados.
- ✓ Observe a vítima como um todo.
- ✓ Confirme as informações.
- ✓ Trabalhe em equipe e comunique-se sempre.
- ✓ Registre com clareza: hora, valores e condições da vítima.



CONHECIMENTO
TÉCNICA
E COMPROMISSO!

PREPARAÇÃO, TÉCNICA E CORAGEM
PARA SALVAR VIDAS!



PÁGINA 10



CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

DISCIPLINA: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH)



3.4 VIA AÉREA E CONTROLE DA COLUNA CERVICAL

A obstrução da via aérea é uma das principais causas de parada cardiorrespiratória evitável. A proteção da coluna cervical é essencial em vítimas de trauma para prevenir lesões neurológicas.

Via aérea pérvia, coluna protegida, vida preservada!



! IMPORTÂNCIA

- ✓ Garante a entrada e saída de ar nos pulmões.
- ✓ Previne hipóxia e complicações graves.
- ✓ Protege a medula espinhal de lesões adicionais.
- ✓ Permite ventilação eficaz e segura.
- ✓ É prioridade em qualquer atendimento.

👤 SINAIS DE OBSTRUÇÃO DA VIA AÉREA

- 👤 Incapacidade de falar.
- 👤 Tosse fraca ou ineficaz.
- 👤 Sinais universais de asfixia (mãos no pescoço).
- 👤 Cianose (lábios e unhas arroxeados).
- 👤 Respiração ruidosa ou ausente.
- 👤 Inconsciência.

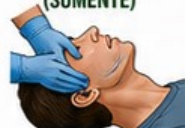
TÉCNICAS DE ABERTURA DE VIA AÉREA

MANOBRA DE INCLINAÇÃO DA CABEÇA E ELEVAÇÃO DO QUEIXO



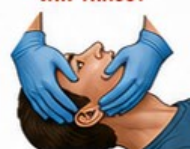
- Indicada para vítimas sem suspeita de trauma.
- Incline a cabeça para trás e eleve o queixo.
- Verifique a respiração.

MANOBRA DE ELEVAÇÃO DO QUEIXO (SOMENTE)



- Indicada para vítimas com suspeita de trauma.
- Eleve apenas o queixo, sem inclinar a cabeça.
- Verifique a respiração.

MANOBRA DE JAW THRUST



- Indicada para vítimas com suspeita de trauma.
- Posicione as mãos nas laterais da cabeça.
- Empurre a mandíbula para frente.

CONTROLE DA COLUNA CERVICAL: REGRAS DE OURO

- ✓ Considere que toda vítima de trauma tem lesão na coluna.
- ✓ Mantenha a cabeça, o pescoço e o tronco alinhados.
- ✓ Imobilize a coluna cervical antes de qualquer movimento.
- ✓ Use colar cervical adequado ao tamanho da vítima.
- ✓ Evite movimentos desnecessários e bruscos.



Use o colar cervical adequado ao tamanho da vítima.



Mantenha a estabilização manual da cabeça até a imobilização completa.



Imobilize em prancha rígida com cintos de segurança.

OBSTRUÇÃO DA VIA AÉREA POR CORPO ESTRANHO

VÍTIMA CONSCIENTE (TOSSE EFICAZ)

- Incentive a vítima a tossir.
- Não realize manobras.
- Monitore continuamente.



VÍTIMA CONSCIENTE (TOSSE INEFICAZ)

- Realize 5 pancadas interescapulares.
- Em seguida, 5 compressões abdominais (manobra de Heimlich).
- Repita até a desobstrução ou perda de consciência.



5 PANCADAS INTERESCAPULARES



5 COMPRESSÕES ABDOMINAIS (HEIMLICH)



VÍTIMA INCONSCIENTE

- Inicie RCP imediatamente.
- Verifique a boca a cada ciclo de RCP em busca do corpo estranho.
- Retire apenas se estiver visível e acessível.



POSIÇÃO LATERAL DE SEGURANÇA (PLS)

Indicada para vítimas inconscientes que respiram normalmente e não há suspeita de trauma.

1



Ajoelhe-se ao lado da vítima.

2



Coloque o braço mais próximo em ângulo reto e leve o dorso da mão à face da vítima.

3



Cruxe o outro braço sobre o tórax e segure a mão da vítima.

4



Dobre a perna mais distante e puxe para o seu lado.

5



Ajuste a posição e verifique a respiração.



ATENÇÃO!

- Nunca mova a vítima sem necessidade.
- Não remova o capacete, a menos que seja essencial para garantir a via aérea ou ventilação.
- A proteção da coluna cervical é responsabilidade de toda a equipe.
- Via aérea pérvia e coluna protegida aumentam as chances de sobrevivência e recuperação.

👍 BOAS PRÁTICAS

- ✓ Aborde a vítima com calma e segurança.
- ✓ Avalie rapidamente e aja com prioridade.
- ✓ Mantenha a comunicação constante.
- ✓ Utilize equipamentos adequados.
- ✓ Reavalie a vítima continuamente.
- ✓ Trabalhe em equipe com coordenação.



CONHECIMENTO, TÉCNICA E CORAGEM A SERVIÇO DA VIDA!

PREPARAÇÃO, TÉCNICA E CORAGEM PARA SALVAR VIDAS!



PÁGINA 11



CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

DISCIPLINA: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH)



3.6 AVALIAÇÃO CARDIOVASCULAR

A avaliação cardiovascular identifica alterações que podem comprometer a circulação e o funcionamento do coração, orientando as condutas e priorizando o atendimento.

Coração bombeia sangue. Circulação leva vida. Avalie sempre com rapidez e precisão!



? POR QUE É IMPORTANTE?

- ✓ Detecta alterações que ameaçam a vida rapidamente.
- ✓ Identifica sinais de choque e perfusão inadequada.
- ✓ Orienta intervenções e necessidade de transporte rápido.
- ✓ Permite monitorar a evolução do paciente.

COMPONENTES DA AVALIAÇÃO CARDIOVASCULAR

FREQUÊNCIA CARDÍACA
Avalie o número de batimentos por minuto.
Valores normais: 60 a 100 bpm (adultos).

RITMO CARDÍACO
Verifique se os batimentos são regulares ou irregulares.

PULSO PERIFÉRICO
Avalie presença, frequência, ritmo e amplitude.
Locais: radial, carotídeo, femoral, pedioso.

PRESSÃO ARTERIAL
Meça sempre que possível.
Valores normais: 90/60 a 120/80 mmHg.

TEMPO DE PREENCHIMENTO CAPILAR (TPC)
Normal: até 2 segundos.
Prolongado: sinais de má perfusão.

COLORAÇÃO DA PELE E MUCOSAS
Observe palidez, cianose, rubor ou moteado.

TEMPERATURA DA PELE
Avalie extremidades: frias podem indicar má perfusão.

VALORES DE REFERÊNCIA (ADULTOS)

Frequência cardíaca (FC): 60 a 100 bpm
Frequência respiratória (FR): 12 a 20 irpm
Pressão arterial (PA): 90/60 a 120/80 mmHg
Tempo de preenchimento capilar: até 2 segundos
Saturação de O₂ (SpO₂): 95% a 100%

ATENÇÃO!

- Qualquer alteração cardiovascular pode evoluir rapidamente.
- Reavalie a cada 5 minutos ou sempre que houver mudança.
- Priorize oxigenação e transporte adequado.

BOAS PRÁTICAS

- Seja rápido, mas não apressado.
- Observe, palpe e meça.
- Confirme dados antes de agir.
- Priorize a vítima: segurança e cuidado.
- Trabalhe em equipe e comunique-se sempre.
- Reavalie sempre! O quadro pode mudar.

COMO AVALIAR: PASSO A PASSO

1



OBSERVE

Observe aspecto geral da vítima: cor, sudorese, nível de alerta.

2



PALPE O PULSO

Palpe o pulso radial ou carotídeo. Conte por 30 segundos e multiplique por 2.

3



AVALIE RITMO E FREQUÊNCIA

Verifique se o ritmo é regular. Anote a frequência cardíaca.

4



MEÇA A PRESSÃO ARTERIAL

Use esfigmomanômetro ou monitor, se disponível. Registre os valores.

5



AVALIE A PERFUSÃO

Verifique TPC, coloração da pele, temperatura e sudorese.

6



REGISTRE E REAVALIE

Anote todos os achados e reavalie constantemente.

SINAIS DE CHOQUE: IDENTIFIQUE E ATUE

TIPO DE CHOQUE	CAUSAS FREQUENTES	SINAIS E SINTOMAS	CONDUTA INICIAL
HIPOVOLÊMICO	Hemorragias, queimaduras, desidratação, vômitos/diarreia.	Taquicardia, hipotensão, palidez, pele fria e úmida, sede intensa, TPC > 2s.	Controle de hemorragias, gerencie via aérea, oxigênio, transporte rápido.
CARDIOGÊNICO	Infarto, insuficiência cardíaca, arritmias graves.	Dispneia, estase jugular, pulso fraco, cianose, hipotensão.	Oxigênio, monitorização, transporte rápido para suporte avançado.
DISTRIBUTIVO	Sepse, reações alérgicas graves (anafilaxia), neurogênico.	Vasodilatação, hipotensão, taquicardia, pele quente ou fria, alteração de nível.	Oxigênio, imobilização, controle da causa, transporte rápido.
OBSTRUTIVO	Tromboembolismo pulmonar, pneumotórax hipertensivo, taponamento cardíaco.	Dispneia súbita, dor torácica, hipotensão, jugular turgente, sons respiratórios diminuídos.	Oxigênio, posicionamento adequado, transporte rápido para intervenção.

SINAIS DE ALERTA CARDIOVASCULARES

- ✓ Dor torácica intensa ou em aperto.
- ✓ Falta de ar súbita.
- ✓ Desmaio ou tontura.
- ✓ Palpitações ou batimentos muito rápidos/lentos.
- ✓ Pulso ausente ou muito fraco.

INTERVENÇÕES INICIAIS

- ✓ Garanta via aérea pérvia e oxigenação.
- ✓ Posicione a vítima conforme o quadro clínico.
- ✓ Controle hemorragias e mantenha aquecimento.
- ✓ Monitore sinais vitais continuamente.
- ✓ Transporte rápido e seguro.

DOCUMENTAÇÃO

- ✓ Registre todos os sinais vitais.
- ✓ Anote horário e condições da avaliação.
- ✓ Descreva alterações e condutas.
- ✓ Comunique à equipe de destino.
- ✓ Reavalie e atualize as informações.



TÉCNICA, CORAGEM E COMPROMISSO COM A VIDA!

PREPARAÇÃO HOJE, PARA SALVAR VIDAS AMANHÃ!



PÁGINA 13



CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

DISCIPLINA: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH)



3.7 AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA

A avaliação respiratória verifica a permeabilidade das vias aéreas, a frequência e a qualidade da respiração, identificando condições que possam comprometer a oxigenação e a vida da vítima.

Respirar é viver. Avalie com atenção e atue com segurança!



PASSO A PASSO DA AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA

1



OBSERVE

Observe o aspecto geral da vítima: cor, sudorese, nível de alerta, uso de músculos acessórios.

2



OUÇA

Aproxime o ouvido e ouça sons da respiração, sem respiradores.

3



SINTA

Sinta o fluxo de ar na face da vítima e verifique movimentos torácicos.

4



CONTE

Conte as incursões respiratórias por 1 minuto (ou por 30 segundos x 2).

5



AVALIE

Avalie padrão, sinais de esforço e presença de alterações.

6



REGISTRE

Registre os dados e reavalie constantemente.

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA (ADULTOS)

PARÂMETRO	NORMAL	ALTERAÇÕES COMUNS
FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR)	12 a 20 irpm	• Taquipneia: > 20 irpm • Bradipneia: < 12 irpm
SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SpO ₂)	95% a 100%	• Hipoxemia: < 95%
PADRÃO RESPIRATÓRIO	Eupneia	• Dispneia, hiperpneia, hipopneia, apneia, respiração irregular
SIMETRIA TORÁCICA	Simétrica	• Assimetria pode indicar lesões torácicas ou pulmonares
ESFORÇO RESPIRATÓRIO	Ausente	• Uso de musculatura acessória, tiragem, batimento de asa de nariz

CONDIÇÕES AVALIADAS



PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS

Verifique se há obstrução por língua, vômito, sangue, secreções ou corpos estranhos.



FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR)

Conte o número de incursões respiratórias por minuto.



TIPO DE RESPIRAÇÃO

Observe o padrão: normal, superficial, profunda, rápida, lenta, irregular ou com esforço.



SIMETRIA E EXPANSIBILIDADE TORÁCICA

Observe o movimento do tórax e se há dor ou assimetria.



ESFORÇO RESPIRATÓRIO

Identifique uso de musculatura acessória, batimento de asa de nariz, tiragem, cianose.



SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SpO₂)

Utilize oxímetro de pulso, se disponível.

VALORES DE REFERÊNCIA (ADULTOS)

Frequência cardíaca (FC): 60 a 100 bpm
Frequência respiratória (FR): 12 a 20 irpm
Pressão arterial (PA): 90/60 a 120/80 mmHg
Tempo de preenchimento capilar: até 2 segundos
Saturação de O₂ (SpO₂): 95% a 100%

SINAIS DE GRAVIDADE RESPIRATÓRIA

- ✓ FR < 8 irpm ou > 30 irpm.
- ✓ SpO₂ < 90%.
- ✓ Batimento de asa de nariz.
- ✓ Cianose (lábios, unhas, extremidades).
- ✓ Respiração irregular ou gasping.
- ✓ Alteração do nível de consciência.
- ✓ Ausência de murmúrio vesicular.

CAUSAS FREQUENTES DE ALTERAÇÕES RESPIRATÓRIAS



Obstrução de vias aéreas (língua, vômito, corpo estranho)



Intoxicações e inalação de fumaça, vapores tóxicos



Doenças respiratórias (asma, DPOC, pneumonia)



Choque e insuficiência cardíaca



Trauma torácico (fraturas, contusões, pneumotórax)



Afogamento e submersão por quase afogamento

INTERVENÇÕES INICIAIS

- ✓ Mantenha a via aérea aberta.
- ✓ Posicione a vítima adequadamente.
- ✓ Remova obstruções visíveis com segurança.
- ✓ Forneça oxigênio, se disponível e indicado.
- ✓ Monitore sinais vitais constantemente.
- ✓ Prepare para suporte ventilatório, se necessário.

DOCUMENTAÇÃO

- ✓ Registre todos os sinais vitais.
- ✓ Anote horário e condições da avaliação.
- ✓ Descreva alterações e condutas.
- ✓ Comunique à equipe de destino.
- ✓ Reavalie e atualize as informações.

ATENÇÃO!

- Nunca mova a vítima sem necessidade.
- Avalie a respiração antes de qualquer intervenção.
- Reavalie a cada 5 minutos ou sempre que houver mudança.
- Comunique alterações imediatamente à equipe médica.

BOAS PRÁTICAS



Seja rápido, mas não apressado.



Observe, palpe e meça.



Mantenha a cabeça em posição neutra.



Use EPIs adequados.



Trabalhe em equipe e registre tudo.



Esteja atento às alterações sutis.



TÉCNICA, CORAGEM
E COMPROMISSO
COM A VIDA!

PREPARAÇÃO HOJE,
PARA SALVAR VIDAS SEMPRE!



PÁGINA 14



CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

DISCIPLINA: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH)



3.8 CONTROLE DE HEMORRAGIAS

Hemorragias são uma das principais causas de morte evitável no trauma. O controle rápido e eficaz do sangramento é fundamental para preservar a vida da vítima até a chegada ao serviço definitivo.

Sangue perdido não volta. Controle agora, salve uma vida!



? POR QUE É IMPORTANTE?

- ✓ Evita choque hipovolêmico e morte.
- ✓ Reduz o tempo de atendimento e complicações.
- ✓ Aumenta as chances de sobrevivência.
- ✓ Permite transporte mais seguro e estável.

TIPOS DE HEMORRAGIAS



HEMORRAGIA ARTERIAL

Sangue vermelho vivo, com jatos pulsáteis e em grande quantidade.



HEMORRAGIA VENOSA

Sangue vermelho escuro, com fluxo contínuo e sem pulsação.



HEMORRAGIA CAPILAR

Sangramento superficial, em forma de "sangue correndo".



HEMORRAGIA INTERNA

Não visível externamente. Pode causar choque sem sinais aparentes.

MÉTODOS DE CONTROLE DE HEMORRAGIAS

1

PRESSÃO DIRETA



- Aplique gaze ou pano limpo diretamente sobre o local.
- Pressione com força constante.
- Mantenha a pressão até o controle do sangramento.

2

PRESSÃO INDIRETA



- Comprima a artéria principal próxima ao local do sangramento.
- Use em sangramentos de membros.

3

CURATIVO COMPRESSIVO



- Após o controle inicial, faça um curativo firme e compressivo.
- Reforce se necessário.

4

GARROTE (TORNIQUETE)



- Use somente em hemorragias graves de membros.
- Posicione 5 a 7 cm acima da lesão.
- Aperte até o sangramento cessar.
- Anote o horário da aplicação.

ATENÇÃO!

- Nunca remova objetos cravados.
- Não aplique torniquete em juntas (cotovelo ou joelho).
- Não afrouxe o torniquete após aplicado.
- Reavalie constantemente a vítima.
- Controle a hemorragia é prioridade antes de outras intervenções.

SINAIS DE CHOQUE HEMORRÁGICO



Pele pálida, fria e úmida



Sede intensa



Pulso rápido e fraco



Visão turva



Respiração rápida



Fraqueza ou tontura



Confusão ou agitação



Perda de consciência

MÉTODO XABCDE – PRIORIDADES

X

Hemorragia exsanguinante (controle imediato)

A

Via aérea com proteção cervical

B

Respiração

C

Circulação

D

Déficit neurológico

E

Exposição e controle ambiental

PASSO A PASSO PARA CONTROLE DE HEMORRAGIAS

1



IDENTIFIQUE

Localize o sangramento e avalie a gravidade.

2



PROTEJA-SE

Use luvas e, se possível, óculos de proteção.

3



APLIQUE PRESSÃO DIRETA

Use gaze ou pano limpo e pressione firmemente.

4



REAVALIE

Verifique se o sangramento cessou ou diminuiu.

5



FAÇA CURATIVO COMPRESSIVO

Imobilize o local com atadura firme.

6



MONITORE E REAVALIE

Observe sinais vitais e reavalie constantemente.



BOAS PRÁTICAS

- ✓ Mantenha materiais de controle de sangramento sempre à mão.
- ✓ Treine as técnicas regularmente.
- ✓ Comunique-se com a equipe durante todo o atendimento.
- ✓ Documente a aplicação do torniquete (horário).



CONTRAINDICAÇÕES DO TORNIQUETE

- ✗ Não utilize em hemorragias que possam ser controladas por outros métodos.
- ✗ Não utilize em membros com fraturas expostas, a menos que seja a única opção.
- ✗ Não utilize em crianças, exceto em situações extremas e com treinamento adequado.
- ✗ Não aplique por mais de 2 horas sem orientação médica.

LEMBRE-SE:

O controle rápido da hemorragia pode ser a diferença entre a vida e a morte.



CONHECIMENTO,
TÉCNICA E CORAGEM
A SERVIÇO DA VIDA!

PREPARAÇÃO HOJE,
PARA SALVAR VIDAS SEMPRE!



PÁGINA 15



CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

DISCIPLINA: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH)



3.9 IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE

A imobilização correta previne o agravamento de lesões e reduz a dor. O transporte seguro e adequado garante que a vítima chegue ao serviço de saúde em melhores condições.

Imobilizar é proteger. Transportar com segurança é cuidar até o destino final!



? POR QUE É IMPORTANTE?

- ✓ Evita agravamento de fraturas e lesões na coluna.
- ✓ Reduz dor e ansiedade da vítima.
- ✓ Garante transporte seguro e eficiente.
- ✓ Aumenta as chances de recuperação.

PRINCÍPIOS DA IMOBILIZAÇÃO

- ✓ Imobilize somente o necessário.
- ✓ Mantenha o alinhamento do segmento lesionado.
- ✓ Não movimente a vítima sem necessidade.
- ✓ Utilize materiais adequados e disponíveis.
- ✓ Reavalie após a imobilização.

TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO

COLUNA CERVICAL



- Use colar cervical adequado (tamanho correto).
- Imobilize a cabeça manualmente até a fixação do colar.

MEMBROS SUPERIORES



- Use tipoia ou imobilizador de braço.
- Imobilize o ombro, cotovelo e punho conforme a lesão.

MEMBROS INFERIORES



- Use talas laterais (pode ser moldável).
- Imobilize articulações acima e abaixo da lesão.

COLUNA TORÁCICA E LOMBAR



- Utilize prancha longa.
- Imobilize cabeça, pescoço, tronco e pelve.

QUADRIL E Pelve



- Use lençol ou cinta pélvica.
- Aperte de forma firme, sem causar dor excessiva.

MATERIAIS UTILIZADOS

- Colar cervical
- Prancha rígida longa
- Talas moldáveis ou rígidas
- Cintas e tirantes
- Tipoia
- Lençol ou cinta pélvica

TRANSPORTE: ESCOLHA DA TÉCNICA

SITUAÇÃO	TÉCNICA INDICADA	OBSERVAÇÕES
Vítima consciente, sem suspeita de lesão na coluna	Transporte em pé ou cadeira de rodas	Avalie tontura, fraqueza ou risco de queda.
Vítima consciente, com suspeita de lesão na coluna	Transporte em cadeira de rodas ou maca com restrição	Imobilize a coluna cervical e mantenha alinhamento.
Vítima inconsciente ou com lesão na coluna	Transporte em maca rígida com imobilização completa	Imobilize cabeça, pescoço, tronco e membros.
Ambientes de difícil acesso (escadas, espaços confinados)	Arrasto ou técnicas de retirada	Utilize técnicas específicas e seguras.

★ REGRAS DE OURO DO TRANSPORTE

- ✓ Planeje o transporte antes de iniciar.
- ✓ Informe o destino e a condição da vítima.
- ✓ Utilize o número mínimo de pessoas necessárias.
- ✓ Movimente a vítima em bloco.
- ✓ Comunicação constante entre a equipe.
- ✓ Mantenha a via aérea pérvia.
- ✓ Monitore sinais vitais durante o transporte.

⚠ ATENÇÃO!

- Não retire o capacete do motociclista sem necessidade.
- Não mova a vítima se houver suspeita de fratura de coluna, pelve ou membros.
- Evite tração nos membros.
- Não transporte a vítima em veículos inadequados (ex.: caçamba, compartimento de carga).

⚠ ERROS COMUNS

- ✗ Não imobilizar adequadamente.
- ✗ Movimentar a vítima sem necessidade.
- ✗ Remover colar cervical inadequadamente.
- ✗ Fixação frouxa nas talas ou cintas.
- ✗ Comunicação falha entre a equipe.

👍 BOAS PRÁTICAS

- ✓ Treine sempre as técnicas de imobilização.
- ✓ Revise o equipamento antes do atendimento.
- ✓ Mantenha a calma e trabalhe em equipe.
- ✓ Respeite os protocolos e limites técnicos.
- ✓ Registre todas as informações da ocorrência.

📋 DOCUMENTAÇÃO

- ✓ Registre tipo de imobilização realizada.
- ✓ Anote materiais utilizados.
- ✓ Descreva a técnica de transporte empregada.
- ✓ Informe alterações e intercorrências.
- ✓ Assine e identifique os responsáveis.

★ BOAS PRÁTICAS GERAIS

- Trabalhe em equipe e de forma sincronizada.

- Respeite os limites da sua formação e função.

- Atualize-se constantemente e pratique.

- Cada detalhe faz a diferença na vida da vítima!

- Sua técnica hoje, é a vida de alguém amanhã!



CONHECIMENTO,
TÉCNICA E CORAGEM
A SERVIÇO DA VIDA!

PREPARAÇÃO HOJE,
PARA SALVAR VIDAS SEMPRE!



PÁGINA 16



CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

DISCIPLINA: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH)



3.10 AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA

A avaliação neurológica rápida identifica alterações no nível de consciência e no funcionamento neurológico da vítima, auxiliando na identificação de lesões graves e na tomada de decisões.

Observe, pergunte, estimule e registre!



? POR QUE É IMPORTANTE?

- ✓ Detecta alterações neurológicas precocemente.
- ✓ Indica gravidade e evolução do quadro.
- ✓ Auxilia na identificação de AVC, TCE e outras condições.
- ✓ Orienta intervenções e necessidade de transporte rápido.

AValiação DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA

Utilize a escala AVPU para uma avaliação rápida:

- A ALERTA** A vítima está acordada, orientada e responde normalmente.
- V VERBAL** A vítima responde ao estímulo verbal (mas não está totalmente orientada).
- P DOR** A vítima não responde ao verbal, mas responde ao estímulo doloroso.
- U NÃO RESPONDE** A vítima não responde a nenhum estímulo.

Reavalie frequentemente e registre as alterações.

AValiação RÁPIDA NEUROLÓGICA



ESCALA DE COMA DE GLASGOW (GCS)

ABERTURA OCULAR (E)	RESPOSTA VERBAL (V)	RESPOSTA MOTORA (M)
4 Espontânea	5 Orientada	5 Obedece comandos
3 Ao verbal	4 Confusa	4 Localiza dor
2 Ao doloroso	3 Palavras inadequadas	3 Retirada à dor
1 Nenhuma	2 Sons incompreensíveis	2 Flexão anormal (decorticação)
	1 Nenhuma	2 Extensão anormal (decerebração)
		1 Nenhuma

INTERPRETAÇÃO GCS

SOMA TOTAL: 3 a 15

- ✓ 13 - 15: Lesão leve
- ✓ 9 - 12: Lesão moderada
- ✓ 3 - 8: Lesão grave

GCS ≤ 8: ALTO RISCO DE COMPROMETIMENTO DA VIA AÉREA

⚠ SINAIS DE ALERTA NEUROLÓGICOS

- ✓ Rebaixamento do nível de consciência.
- ✓ Confusão mental ou desorientação.
- ✓ Dificuldade para falar ou entender.
- ✓ Fraqueza ou dormência em membros.
- ✓ Desvio do olhar ou assimetria facial.
- ✓ Convulsões.
- ✓ Dor de cabeça intensa súbita.
- ✓ Vômitos persistentes.
- ✓ Dificuldade para andar ou manter o equilíbrio.

⚠ ATENÇÃO!

- Sempre proteja a coluna cervical durante a avaliação.
- Não agite ou movimente desnecessariamente a vítima.
- Estímulos dolorosos devem ser aplicados com cautela e apenas quando necessário.
- Reavalie frequentemente e registre todas as alterações.

👍 BOAS PRÁTICAS

- ✓ Fale com a vítima e observe suas reações.
- ✓ Use linguagem clara e tom de voz firme.
- ✓ Avalie ambos os lados do corpo.
- ✓ Mantenha a vítima aquecida e confortável.
- ✓ Trabalhe em equipe e comunique-se sempre.

📋 DOCUMENTAÇÃO

- ✓ Registre o GCS e a escala AVPU.
- ✓ Descreva as alterações encontradas.
- ✓ Anote horário das avaliações.
- ✓ Comunique à equipe e no handover.
- ✓ Reavalie e atualize as informações.

CAUSAS COMUNS DE ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS

- 🗨 Traumatismo craniocerebral (TCE)
- 🗨 Acidente vascular cerebral (AVC)
- 🗨 Hipoglicemia ou hiperglicemia
- 🗨 Sobredose ou intoxicações
- 🗨 Hipóxia ou hipóxia tecidual
- 🗨 Infecções do sistema nervoso

PASSO A PASSO DA AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA



CONHECIMENTO,
TÉCNICA E CORAGEM
A SERVIÇO DA VIDA!

PREPARAÇÃO HOJE,
PARA SALVAR VIDAS SEMPRE!



PÁGINA 17



BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

DISCIPLINA: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH)



3.11 SUPORTE BÁSICO DE VIDA (SBV)

O Suporte Básico de Vida (SBV) é o conjunto de condutas que visam manter a circulação e a oxigenação do organismo em situações de parada cardiorrespiratória (PCR), até a chegada do suporte avançado.

Sua atitude rápida pode salvar uma vida!



? POR QUE É IMPORTANTE?

- ✓ A PCR pode ocorrer em qualquer lugar e a qualquer hora.
- ✓ A cada minuto sem RCP, as chances de sobrevivência diminuem cerca de 10%.
- ✓ O SBV imediato pode dobrar ou triplicar as chances de sobrevivência.

RECONHECIMENTO DA PCR

Verifique rapidamente:

- ✓ Não responde a estímulos.
- ✓ Não respira ou respiração anormal (gaspings).
- ✓ Não possui pulso ou pulso ausente/incerto.



ATENÇÃO!

Não perca tempo procurando o pulso se não tiver certeza. Inicie as compressões torácicas imediatamente!

CADEIA DE SOBREVIVÊNCIA



Reconhecimento e acionamento do serviço de emergência



RCP precoce



Desfibrilação precoce



Suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR

COMPRESSÕES TORÁCICAS DE ALTA QUALIDADE



- ✓ Posição correta: centro do tórax (metade inferior do esterno).
- ✓ Profundidade: 5 a 6 cm.
- ✓ Frequência: 100 a 120 compressões por minuto.
- ✓ Permita o retorno completo do tórax.
- ✓ Minimize interrupções das compressões.

VENTILAÇÕES

- ✓ Realize 2 ventilações após 30 compressões (relação 30:2).
- ✓ Cada ventilação deve durar cerca de 1 segundo.
- ✓ Observe a elevação do tórax.
- ✓ Se não houver elevação, reabra a via aérea e tente novamente.

Se não puder ou não souber ventilar, realize compressões contínuas (apenas compressões).



DESFIBRILAÇÃO PRECOCE (DEA)

O uso precoce do DEA aumenta significativamente as chances de sobrevivência.

- ✓ Ligue o DEA e siga as instruções.
- ✓ Cole os eletrodos no tórax do paciente.
- ✓ Afaste-se e analise o ritmo.
- ✓ Se indicado, aplique o choque.
- ✓ Retorne imediatamente as compressões após o choque.



SEQUÊNCIA DE SBV EM ADULTOS

1



Avalie a segurança do local.



2



Verifique resposta e respiração.



3



Acione o serviço de emergência (193).



4



Inicie 30 compressões torácicas de alta qualidade.



5



Realize 2 ventilações.



6



Use o DEA assim que disponível.



7



Continue o ciclo 30:2 até chegada do suporte avançado ou recuperação da vítima.

ATENÇÕES IMPORTANTES

- Inicie as compressões imediatamente.
- Não interrompa as compressões desnecessariamente.
- Troque de compressor a cada 2 minutos ou antes se necessário.
- Mantenha ritmo e profundidade adequados.
- Sua segurança vem sempre em primeiro lugar.

ERROS COMUNS

- ✗ Não acionar o serviço de emergência.
- ✗ Compressões rasas ou muito lentas.
- ✗ Interromper as compressões por muito tempo.
- ✗ Ventilações excessivas ou incompletas.
- ✗ Não utilizar o DEA quando disponível.

SITUAÇÕES ESPECIAIS

- ✳ Se houver mais de um socorrista, alterne as funções.
- ✳ Em afogamento: realize 5 ventilações iniciais antes das compressões.
- ✳ Em crianças: relação 30:2 com compressões mais suaves (profundidade 1/3 do tórax).
- ✳ Em lactentes: use 2 dedos para compressões.

DOCUMENTAÇÃO

- ✓ Registre todas as ações realizadas.
- ✓ Anote horários: início da PCR, RCP, choques, medicamentos (se aplicável).
- ✓ Informe a equipe de destino sobre a evolução e condutas realizadas.
- ✓ A documentação é essencial para a continuidade do cuidado.

BOAS PRÁTICAS

Treine sempre.



Mantenha a calma e lidere a cena.



Comunique-se claramente.



Trabalhe em equipe.



Revise protocolos e atualizações.

LEMBRE-SE:

Cada segundo conta. Sua ação rápida e correta pode fazer a diferença entre a vida e a morte.



CONHECIMENTO,

PREPARAÇÃO HOJE

10



BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH)



3.12 ATENDIMENTO À PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR)

A Parada Cardiorrespiratória (PCR) é uma emergência médica crítica em que o coração para de bater e a vítima para de respirar. O reconhecimento imediato e o início rápido das manobras de RCP e do uso do DEA podem fazer a diferença entre a vida e a morte.

Cada segundo conta. Sua ação pode salvar uma vida!



? POR QUE É IMPORTANTE?

- ✓ As chances de sobrevivência caem cerca de 10% a cada minuto sem RCP.
- ✓ O início imediato das compressões duplica ou triplica as chances de sobrevivência.
- ✓ O DEA pode aumentar a chance de sobrevivência em até 70%.
- ✓ Ação rápida reduz sequelas neurológicas.

RECONHECIMENTO DA PARADA

Verifique rapidamente:

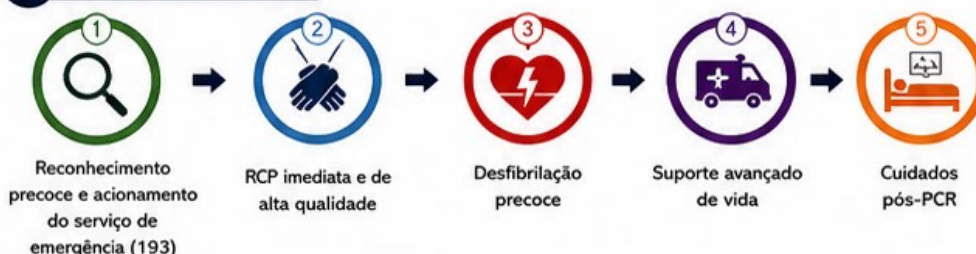
- ✓ Não responde a estímulos.
- ✓ Não respira ou respiração anormal (gaspings).
- ✓ Não possui pulso ou pulso ausente/incerto.



ATENÇÃO!

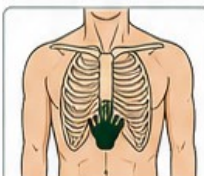
Em caso de dúvida, trate como PCR e inicie as compressões.

CADEIA DE SOBREVIVÊNCIA



RCP DE ALTA QUALIDADE – ADULTO

POSIÇÃO DAS MÃOS



Centro do tórax,
sobre o esterno
(entre os mamilos).

COMPRESSÕES

- Profundidade: 5 a 6 cm.
- Frequência: 100 a 120 compressões por minuto.
- Permita o retorno completo do tórax.
- Minimize interrupções das compressões.

30

compressões

VENTILAÇÕES



- Realize 2 ventilações após 30 compressões.
- Cada ventilação deve durar cerca de 1 segundo.
- Observe a elevação do tórax.

2 ventilações

RÁCIO



Continue o ciclo
30 compressões
para 2 ventilações.

TROCA DE SOCORRISTA



Revezar a cada 2 minutos
ou antes, se possível,
para manter a qualidade
das compressões.

USO DO DEA



- Ligue o DEA e siga as instruções por voz.
- Cole os eletrodos no tórax desnudo do paciente.
- Afaste-se e analise o ritmo.
- Se indicado, aplique o choque.
- Retorne imediatamente as compressões por 2 minutos.

SINAIS DE PCR

- ✗ Inconsciência súbita.
- ✗ Ausência de respiração ou gasping.
- ✗ Ausência de pulso.
- ✗ Pele pálida ou arroxeada.
- ✗ Pupilas dilatadas.

CAUSAS REVERSÍVEIS – 5H e 5T

5H

- Hipóxia
- Hipovolemia
- Hipo/Hipercalcemia
- Hipotermia
- Hidrogênio (acidose)

5T

- Tensão no tórax (pneumotórax)
- Tamponamento cardíaco
- Toxinas
- Trombose coronariana
- Trombose pulmonar

SITUAÇÕES ESPECIAIS

- ✓ Afogamento: priorize ventilações iniciais (5 ventilações) antes de iniciar as compressões.
- ✓ Crianças (1 até 8 anos): 15:2 (um ou dois socorristas).
- ✓ Lactentes (até 1 ano): 15:2 (dois socorristas) ou 30:2 (um socorrista).
- ✓ Gestantes: desloque o útero para a esquerda (descompressão aortocava).

DOCUMENTAÇÃO

- ✓ Registre o horário do início da PCR.
- ✓ Anote as ações realizadas e os tempos.
- ✓ Registre o número de choques aplicados.
- ✓ Informe a evolução e o desfecho.
- ✓ Comunicar à equipe e ao serviço de destino.
- ✓ A documentação é legal e essencial para a continuidade do cuidado.

PASSO A PASSO DO ATENDIMENTO À PCR



BOAS PRÁTICAS

- ✓ Mantenha compressões firmes, rápidas e contínuas.
- ✓ Minimize interrupções.
- ✓ Comunique-se com a equipe.
- ✓ Utilize recursos disponíveis (DEA, oxigênio, materiais).
- ✓ Treine continuamente suas habilidades.

ERROS COMUNS

- ✗ Não iniciar a RCP por hesitação.
- ✗ Compressões rasas ou muito lentas.
- ✗ Interromper as compressões com frequência.
- ✗ Ventilações excessivas.
- ✗ Não usar o DEA quando disponível.

LEMBRE-SE!

A qualidade da RCP é o fator mais importante para a sobrevivência e recuperação neurológica da vítima. Seja rápido, seja eficaz, seja o primeiro elo da cadeia de vida!





BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

DISCIPLINA: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH)



3.13 OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS POR CORPO ESTRANHO (OVACE)

A OVACE ocorre quando um objeto impede parcial ou totalmente a passagem de ar pela via aérea. A identificação rápida e a conduta correta podem salvar vidas e evitar complicações graves.

Reconheça, ajoelhe-se ao lado da vítima e aja com segurança!



? POR QUE É IMPORTANTE?

- ✓ A obstrução total pode levar à parada cardiorrespiratória.
- ✓ A ação rápida pode desobstruir e salvar a vida.
- ✓ Conhecer as manobras corretas evita agravamentos.
- ✓ Cada segundo conta para manter a oxigenação.

IDENTIFICAÇÃO DA OVACE

A vítima pode apresentar:

- ✓ Não consegue falar.
- ✓ Não consegue tossir com força.
- ✓ Dificuldade ou ausência de respiração.
- ✓ Sinais de sufocamento (mãos no pescoço).
- ✓ Alteração da cor da pele (cianose).

TIPOS DE OBSTRUÇÃO

OBSTRUÇÃO PARCIAL

(Leve)



- A vítima consegue tossir.
- Consegue falar.
- Consegue respirar.
- Estimule a tosse.

NÃO realize palmadas ou compressões abdominais!

OBSTRUÇÃO TOTAL

(Grave)



- Não consegue tossir.
- Não consegue falar.
- Não consegue respirar.
- Ação imediata necessária!

SINAIS DE GRAVIDADE

- ✓ Incapacidade de falar ou emitir sons.
- ✓ Ausência de tosse eficaz.
- ✓ Respiração ausente ou muito fraca.
- ✓ Cianose (lábios, unhas e pele azuladas).
- ✓ Perda de consciência.

Se a vítima perder a consciência, inicie RCP imediatamente!

MANOBRAS DE DESOBSTRUÇÃO

1 ADULTO E CRIANÇA MAIOR DE 1 ANO

1 Verifique a obstrução

Pergunte: "Você está engasgado?"

Se não conseguir falar ou tossir, é obstrução total.

2 5 Palmadas nas costas

Incline a vítima para frente e dê 5 palmadas firmes entre as escápulas.

3 5 Compressões abdominais

Posicione-se atrás da vítima. Faça 5 compressões rápidas acima do umbigo e abaixo do esterno.

4 Repita o ciclo

Continue alternando 5 palmadas e 5 compressões até a obstrução ser aliviada ou a vítima perder a consciência.

5 Vítima inconsciente

Deite cuidadosamente. Acione o 193 e inicie RCP, verificando a boca a cada ciclo.

2 LACTENTE (MENOR DE 1 ANO)

1 Posicione o lactente

Segure o bebê de braços sobre seu antebraço, com a cabeça mais baixa que o tronco.

2 5 Palmadas nas costas

Dê 5 palmadas firmes nas costas do bebê entre as escápulas.

3 5 Compressões torácicas

Vire o bebê de costas, com a cabeça mais baixa. Faça 5 compressões no centro do tórax.

4 Repita o ciclo

Continue alternando 5 palmadas e 5 compressões até a obstrução ser aliviada ou o bebê ficar inconsciente.

5 Bebê inconsciente

Acione o 193 e inicie RCP (30:2) com técnica adequada para lactente. Verifique boca a cada ciclo.

CADEIA DE SOBREVIVÊNCIA – OVACE



SE A VÍTIMA FICAR INCONSCIENTE

- 1 Deite a vítima com cuidado.
- 2 Acione o serviço de emergência (193).
- 3 Inicie RCP imediatamente.
- 4 A cada ciclo de 30 compressões, verifique a boca e remova o objeto, se visível.
- 5 Continue até a chegada do socorro ou retorno de sinais de vida.

O QUE NÃO FAZER

- ✗ Não fazer varredura às cegas na boca.
- ✗ Não dar água ou alimentos.
- ✗ Não realizar compressões abdominais em gestantes ou obesos (risco de lesão).
- ✗ Não demorar para iniciar as manobras.
- ✗ Não abandonar a vítima.

POSIÇÃO PARA COMPRESSÕES ABDOMINAIS

- Posicione-se atrás da vítima.
- Feche um punho e coloque acima do umbigo e abaixo do esterno.
- Segure o punho com a outra mão.
- Puxe firmemente para dentro e para cima.

ATENÇÕES IMPORTANTES

- A tosse é um mecanismo de defesa. Estimule-a na obstrução parcial.
- Aja com calma, mas com rapidez.
- Adapte a força das manobras ao porte da vítima.
- Treine sempre as técnicas para estar preparado.
- Sempre que possível, reavalie a vítima após cada ciclo de manobras.

SITUAÇÕES ESPECIAIS

- ✳ Vítimas obesas: faça compressões torácicas em vez das abdominais.
- ✳ Gestantes: faça compressões torácicas.
- ✳ Cadeirantes: posicione-se lateralmente e faça compressões torácicas.
- ✳ Auto-obstrução: em caso de obstrução, a vítima pode fazer compressões abdominais em si mesma (técnica da cadeira).

DOCUMENTAÇÃO

- ✓ Registre a ocorrência detalhadamente.
- ✓ Anote os sinais e sintomas apresentados.
- ✓ Informe as manobras realizadas.
- ✓ Registre a evolução da vítima.
- ✓ Informe o serviço de destino.
- ✓ A documentação é essencial para a continuidade do cuidado.

BOAS PRÁTICAS

- ✓ Esteja atento ao ambiente durante as refeições.
- ✓ Eduque sobre prevenção de engasgos.
- ✓ Mantenha a calma e transmita confiança.
- ✓ Trabalhe em equipe e comunique-se.
- ✓ Atualize-se sempre sobre as técnicas.



EM CASO DE DÚVIDA OU AGRAVAMENTO, ACIONE IMEDIATAMENTE O SERVIÇO DE EMERGÊNCIA!
Sua preparação e atitude podem salvar uma vida.



**Conhecimento + Técnica + Coragem
= Vidas Salvas!**



BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

DISCIPLINA: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH)



3.18 VIA AÉREA: DISPOSITIVOS E TÉCNICAS AUXILIARES

Dispositivos e técnicas podem ser necessários para manter a via aérea pérvia, especialmente em vítimas inconscientes ou com risco de obstrução.

Conheça. Indique. Aplique com técnica. Salve vidas!

? POR QUE É IMPORTANTE?

- ✓ Mantêm a via aérea aberta e facilitam a ventilação.
- ✓ Reduzem o risco de aspiração de secreções ou vômitos.
- ✓ Ajudam a prevenir hipóxia e complicações graves.
- ✓ São aliados valiosos até a chegada ao hospital.



DISPOSITIVOS OROFARÍNGEOS (GUEDEL)



- Impedem a língua de cair para trás e obstruir a via aérea.
- Utilizados em vítimas inconscientes sem reflexo de vômito.
- Escolher o tamanho adequado.
- Inserir com a concavidade voltada para cima.

TAMANHO RECOMENDADO (ADULTO)

- Amarelo (6,0 cm) – Pequeno
- Vermelho (7,0 cm) – Médio
- Verde (8,0 cm) – Grande
- Laranja (9,0 cm) – Extra grande
- Azul (10,0 cm) – Extra extra grande

TÉCNICA: INSERÇÃO DO GUEDEL



ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES



- Aspire apenas o que for visível.
- Não ultrapasse 10–15 segundos.
- Pressão recomendada: 80–120 mmHg.
- Oriente para o lado (se possível).
- Fundamental em vítimas com vômitos, sangramentos ou secreções.

DISPOSITIVO NASOFARÍNGEO (SONDA NASAL)



- Indicado para vítimas com trauma facial, trismo ou quando o GUEDEL não pode ser utilizado.
- Medir da narina até o lóbulo da orelha.
- Lubrificar e inserir com leve rotação.
- Confirmar posicionamento correto.



ATENÇÃO!

Contraindicado em fraturas de base de crânio (sangramento nasal e otorrêia).

MANOBRAS DE ABERTURA DE VIA AÉREA

ELEVAÇÃO DO QUEIXO (Sem trauma)



- Puxe o queixo para cima com os dedos.
- Mantenha a cabeça em posição neutra.

ELEVAÇÃO DA MANDÍBULA (Com trauma cervical)



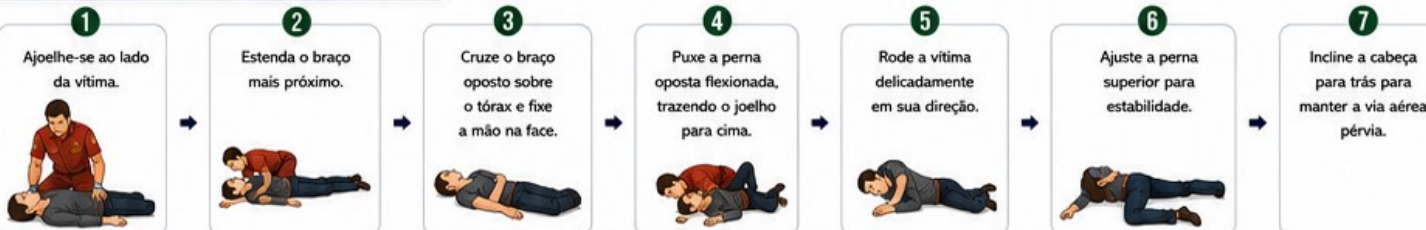
- Posicione as mãos atrás dos ângulos da mandíbula.
- Eleve a mandíbula sem inclinar a cabeça.

POSIÇÃO LATERAL DE SEGURANÇA (PLS)



- Utilizada em vítimas conscientes ou inconscientes que respiram normalmente.
- Previne aspiração de vômitos e secreções.
- Reavalie a cada 2 minutos.

PASSO A PASSO: POSIÇÃO LATERAL DE SEGURANÇA



ATENÇÕES IMPORTANTES

- Nunca deixe a vítima sozinho.
- Reavalie ABC a cada 2 minutos.
- Mantenha a via aérea pérvia.
- Proteja a coluna cervical quando houver suspeita de trauma.
- Comunicação constante com a equipe.

ERROS COMUNS

- ✗ Inserir GUEDEL em vítima consciente.
- ✗ Usar tamanho inadequado.
- ✗ Forçar a inserção do dispositivo.
- ✗ Inclinar demais a cabeça em trauma.
- ✗ Aspirar por tempo prolongado.

BOAS PRÁTICAS

- ✓ Escolher o dispositivo correto.
- ✓ Agir com calma e técnica.
- ✓ Reavaliar constantemente.
- ✓ Registrar procedimentos realizados.
- ✓ Trabalhar em equipe.

DOCUMENTAÇÃO

- ✗ Registre o dispositivo utilizado.
- ✗ Anote o horário da aplicação.
- ✗ Descreva a resposta da vítima.
- ✗ Informe intercorrências.
- ✗ Comunicação clara e objetiva.

DICA DO INSTRUTOR

A via aérea pérvia é o primeiro passo para garantir oxigenação e salvar vidas!

LEMBRE-SE!



SEGURANÇA
Sua segurança em primeiro lugar.



AVALIAÇÃO
Avalie, identifique e direcione.



TÉCNICA
Use a técnica correta sempre.



COMPASSÃO
Trate a vítima com respeito.



RESULTADO
Cada ação certa faz a diferença!